

Compromisso e manejo de crises

Conduzido por Andressa Juliana, com Júlio Gonçalves

Material de apoio — resumo fiel ao que foi dito no encontro

O ESSENCIAL

- **Compromisso em DBT não é adesão passiva.** É um combinado explícito, revisitado ao longo do tratamento: permanência mínima, frequência, pagamento.
- **O terapeuta não é a rede de apoio da pessoa nem seu salvador.** Um caso de risco só deve ser assumido com rede social estruturada e acompanhamento psiquiátrico.
- **Perguntar diretamente sobre ideação suicida não induz o comportamento.** A evidência disponível aponta na direção oposta: costuma validar o sofrimento.
- **O plano de crise é obrigatório para todo paciente em DBT**, não um recurso reservado aos casos mais graves — e é revisado a partir das próprias análises em cadeia.
- **Depois de uma tentativa ou automutilação, o contato do terapeuta pausa por 24h.** A razão é comportamental: evitar que a atenção reforce o comportamento extremo.

01 O que é compromisso, em DBT

O compromisso não é a assinatura de um termo no início do tratamento. É um processo ativo e contínuo de escolha, que o paciente reafirma — ou renegocia — em vários momentos, não só naquele primeiro encontro. Engajar a pessoa no tratamento começa antes mesmo de tratar: no pré-tratamento, quando se avalia se a DBT é de fato a abordagem certa para aquele momento da vida dela.

A DBT raramente é o primeiro tratamento que a pessoa procura. É comum que já tenha passado por experiências terapêuticas anteriores problemáticas ou inadequadas. O pré-tratamento serve exatamente para avaliar o funcionamento geral, o risco de vida, os tratamentos já tentados, e se a abordagem é de fato adequada ao momento daquela pessoa.

02 Os limites do papel terapêutico

Um ponto insistido em aula: o terapeuta não pode assumir o papel de salvador nem se tornar a única rede de apoio do paciente. O trabalho de mudança é feito pela pessoa em conjunto com sua rede social e com o acompanhamento psiquiátrico, não pelo terapeuta sozinho.

Sem rede, o caso não deve ser assumido

Casos de risco elevado não devem ser assumidos sem uma rede de apoio estruturada e sem acompanhamento psiquiátrico ativo. Aceitar um caso assim sem essas condições sobrecarrega a profissional e piora o manejo do risco, não melhora.

Isso não é uma exceção clínica: profissionais de psicologia têm o direito de escolher quais casos atender e de respeitar seus próprios limites técnicos e pessoais para evitar o esgotamento (burnout). Quando a demanda excede a disponibilidade real, o encaminhamento seguro é a conduta correta, mesmo que gere sentimentos de rejeição ou de idealização por parte de quem é atendido.

FIGURA 1 · QUEM SUSTENTA O CASO



Um caso de risco elevado só deve ser assumido quando os três apoios existem de fato — não apenas o vínculo com o terapeuta.

03 Avaliação do risco de suicídio e autolesão

Perguntar de forma direta sobre ideação suicida — ativa ou passiva — não instiga o comportamento. Ao contrário: costuma validar o sofrimento e abrir espaço para que a pessoa fale do que, de outro modo, ficaria calado. Revisões sistemáticas não encontram evidência de que perguntar sobre suicídio aumente a ideação (Dazzi et al., 2014).

A avaliação investiga, no mínimo: existência de plano estruturado (quando, onde, como), tentativas anteriores, e acesso a meios letais — medicações em quantidade, armas de fogo, outros métodos disponíveis.

Diretriz prática

Coletar contatos completos da rede de apoio e documentos do paciente já no pré-tratamento, antes da primeira sessão de fato. Numa crise em que a pessoa recuse ajuda, é isso que garante à equipe como acionar alguém.

04 Instrumentos estruturados de avaliação

Dois instrumentos foram citados como apoio à documentação e à tomada de decisão clínica: o **formulário do Botega**, para visualização rápida dos fatores de risco (Botega, 2021), e o **LRAMP** — Linehan Risk Assessment and Management Protocol —, desenvolvido por Marsha Linehan especificamente para pacientes em DBT, detalhando a razão da avaliação, a descrição da ameaça, fatores de risco e protetivos, histórico de tentativas e intervenções realizadas (Carmel et al., 2018).

A recomendação que atravessa os dois é a mesma: documentar rigorosamente toda comunicação, encaminhamento e registro no prontuário. Isso protege o paciente, porque força uma avaliação sistemática, e protege juridicamente a profissional.

FIGURA 2 · DO SINAL DE RISCO AO REGISTRO



05 Manejo a curto prazo

Diante de um risco iminente, a primeira linha de ação é afastar o acesso a meios letais: pedir a devolução de caixas de medicamento excedentes ao trocar uma prescrição, coordenar o controle das doses com a rede de apoio e com o psiquiatra responsável.

- Suporte emocional direto, no momento em que a pessoa procura
- Vigilância familiar temporária, combinada com a rede
- Programação de atividades para preencher o tempo de maior risco
- Sessões mais frequentes ou mais curtas — por exemplo, 30 minutos, duas vezes por semana
- Coaching telefônico entre sessões
- Reavaliação contínua do risco, não uma avaliação única e fechada

06 Tratamento a médio e longo prazo

Enquanto o manejo de curto prazo garante a segurança imediata, o trabalho de médio e longo prazo mira as condições subjacentes: diagnóstico e tratamento de quadros como transtorno bipolar ou episódios mistos, os estressores crônicos que alimentam a crise, e a modificação sustentada dos comportamentos disfuncionais.

Isso exige assegurar a adesão a tratamentos complementares — participação no grupo de treinamento de habilidades e acompanhamento psiquiátrico ou neurológico quando indicado — e não apenas a presença nas sessões individuais.

07 Hospitalização: quando considerar

A DBT não é contrária à hospitalização, mas também não a trata como resposta automática para qualquer sinal de risco. A internação é indicada em situações específicas: psicose, risco agudo severo, episódios maníacos ou mistos de transtorno bipolar, e transições complexas de medicação que exigem supervisão de enfermagem.

Cuidado com o reforço operante

Algumas pessoas buscam a internação pelo alívio que ela proporciona, ou reforçam operantemente a ameaça suicida como forma de obter cuidado. Avaliar o risco real — e não apenas a intensidade do pedido — evita reforçar um estilo de vida organizado em torno de crises e internações recorrentes.

FIGURA 3 · O MANEJO POR HORIZONTE DE TEMPO

Curto prazo	Médio / longo prazo	Hospitalização
• Meios letais fora de alcance • Vigilância familiar • Programação de atividades • Sessões mais frequentes • Coaching telefônico • Reavaliação contínua	• Diagnóstico e tratamento de base • Estressores crônicos • Adesão ao grupo de habilidades • Acompanhamento psiquiátrico regular	exceção, não rotina • Psicose • Risco agudo severo • Episódio maníaco ou misto • Transição complexa de medicação

As três frentes coexistem — a hospitalização não substitui as outras duas, é reservada para quando elas não bastam.

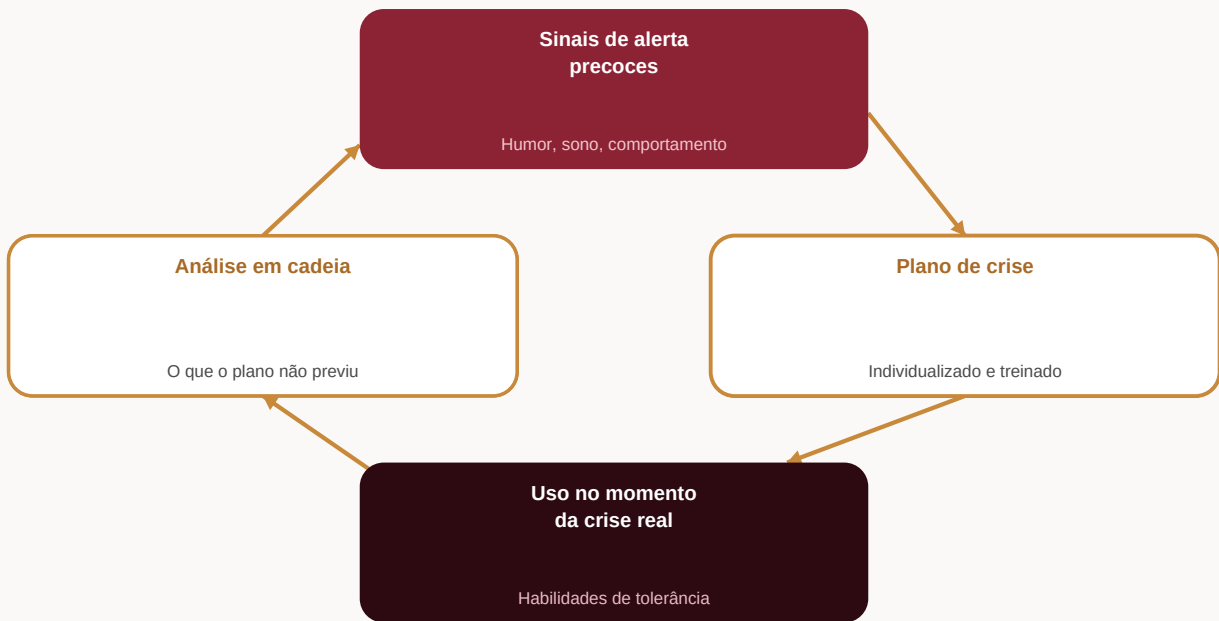
08 O plano de crise

O plano de segurança contra crises é uma intervenção breve, validada e obrigatória para todo paciente em DBT — não um recurso reservado aos casos mais graves. Ele pode cobrir diferentes tipos de crise: desregulação emocional aguda, compulsão alimentar, uso excessivo de medicação.

- **Individualizado** — construído a partir da história e dos gatilhos específicos daquela pessoa
- **Treinado colaborativamente** — não é entregue pronto, é ensaiado com o paciente
- **Revisado constantemente** — a partir das análises em cadeia dos momentos críticos que de fato aconteceram

O elemento central é identificar sinais de alerta precoces — mudanças de humor, de padrão de sono, de comportamento — para intervir antes que a pessoa atinja o pico da dor, quando os métodos desadaptativos rápidos passam a parecer a única saída.

FIGURA 4 · O CICLO DO PLANO DE CRISE



O plano nunca é definitivo — cada crise real, revisitada em análise em cadeia, refina os sinais de alerta da próxima volta.

09 Tolerância ao mal-estar no pico da crise

As estratégias de tolerância ao mal-estar não eliminam a emoção — servem para reduzir sua intensidade e tirar a pessoa do pico da crise até que ela consiga acessar outras habilidades.

- **Distração 5-4-3-2-1** — cinco coisas para ver, quatro para sentir, três sons, dois cheiros e um gosto, geralmente antes de um trabalho de respiração
- **Respiração compassada** — a expiração mais longa que a inspiração ativa o parassimpático; preferível à diafragmática isolada em quem é vulnerável a pânico
- **TIP** — água ou compressa gelada no rosto e na nuca, exercício físico intenso, gelo nas mãos, pontos de pressão, sabores intensos
- **Kit de emergência** — fones com playlist de crise, fotos com motivos para viver, técnicas impressas, cartões de enfrentamento, e um desenho colorido do próprio plano

10 Coaching telefônico

O contato entre sessões tem três alvos, nessa ordem de prioridade: reduzir comportamento suicida, generalizar habilidades para a vida real, resolver conflitos com o terapeuta.

O formato é deliberadamente breve e estruturado — ligações de 10 a 20 minutos, ou mensagens — seguindo um roteiro fixo: onde a pessoa está, quem está com ela, a intensidade da emoção e do impulso, e quais habilidades já foram ou serão usadas. Não é uma sessão reduzida; é uma intervenção de coaching no momento do impulso.

FIGURA 5 · OS TRÊS ALVOS DO COACHING, EM ORDEM

1 · Reduzir comportamento suicida ou de autolesão

2 · Generalizar habilidades para a vida real

3 · Resolver conflitos com o terapeuta

A largura marca a prioridade, não o tempo de ligação.

11 Depois de uma crise

Em caso de tentativa de suicídio ou automutilação, o contato do terapeuta é suspenso por 24 horas. A razão é comportamental, não punitiva: evitar que a atenção excessiva do terapeuta reforce o comportamento extremo.

A prioridade absoluta nesse momento é a segurança médica imediata — acionar a rede de apoio ou serviços de emergência como o SAMU. O retorno ao plano de tratamento regular acontece assim que o risco agudo diminui.

12 Uma vida que vale a pena, e o sigilo

O foco da terapia não é apenas a ausência de comportamento suicida — é ajudar a pessoa a construir uma vida que valha a pena ser vivida. Isso significa trabalhar o plano de crise e validar o sofrimento sem, ao mesmo tempo, reforçar os comportamentos desadaptativos que a pessoa usa para lidar com ele.

O sigilo é quebrado desde o pré-tratamento sempre que houver risco de vida para o paciente ou para terceiros — isso é combinado com a pessoa antes de começar, não decidido no meio de uma crise, e aciona obrigatoriamente a rede de apoio.

13 O contrato de compromisso

A DBT trata o compromisso como parte estrutural do tratamento, não como formalidade em torno dele. Os pontos combinados em contrato, na aula, foram estes:

- **Permanência:** compromisso inicial de um ano em tratamento, com possibilidade de renovação — horizonte necessário para resultados consistentes.
- **Faltas:** quatro faltas consecutivas, tanto na terapia individual quanto no treinamento de habilidades, resultam em desligamento do tratamento. Alguns profissionais adotam um limite mais restritivo em contrato próprio — no caso da aula, duas faltas consecutivas.
- **Pagamento:** os acordos precisam constar expressamente em contrato; inadimplência prolongada compromete a viabilidade do processo terapêutico.

Há espaço para adaptação individualizada do treinamento de habilidades em casos específicos, mas essa flexibilidade é a exceção negociada, não a regra de partida. **Metas de vida** (o que a pessoa gostaria de viver caso não tivesse os problemas atuais) são diferentes de **alvos terapêuticos** (a eliminação dos comportamentos desadaptativos que impedem o caminho até essas metas).

14 Perguntas de revisão

Responda por escrito. Há campos para digitar se abrir este PDF num leitor compatível (Acrobat, Preview) — senão, imprima e responda à mão.

01. Uma paciente relata ideação suicida passiva pela primeira vez. Tu evita perguntar sobre plano e meios letais para “não plantar a ideia”?

02. Um paciente liga fora do horário de coaching, em crise, mas passa a sessão inteira falando sobre um conflito no trabalho. Isso é coaching de crise?

03. Depois de uma tentativa de suicídio, o paciente manda mensagens repetidas pedindo para conversar. Por que a orientação é suspender o contato por 24 horas, e o que fazer nesse intervalo?

15 Referências

- Botega, N. J. (2021). *Crise suicida: avaliação e manejo* (2ª ed.). Artmed.
- Carmel, A., Templeton, E., Sorenson, S. M., & Logvinenko, E. (2018). Using the Linehan Risk Assessment and Management Protocol with a chronically suicidal patient: A case report. *Cognitive and Behavioral Practice*, 25(4), 449–459.
- Dazzi, T., Gribble, R., Wessely, S., & Fear, N. T. (2014). Does asking about suicide and related behaviours induce suicidal ideation? What is the evidence? *Psychological Medicine*, 44(16), 3361–3363.
- Linehan, M. M. (1993). *Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder*. Guilford Press.
- Linehan, M. M. (2015). *DBT skills training manual* (2ª ed.). Guilford Press.

Nota de método

Resumo escrito a partir da transcrição do encontro, conduzido por Andressa Juliana. As referências ao Botega e ao LRAMP foram formalizadas a partir do que foi citado em aula; a nota sobre perguntar diretamente sobre suicídio foi complementada com uma revisão sistemática real, por não ter sido citada uma fonte específica no encontro. Nenhum caso clínico real foi usado nesta aula.